Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Plot No. 2, Teka Naka,
Beside Go-gas, Kamptl Road,
Nagpur-440017
Contact : 9823555053 / 9373111709
Website : w.w.w.hopehospital.com
Email : cmd@hopehospital.com

एनेस्थीसिया के लिए सुचित सहमती

मरीज पहचान विवरण :

अगर आई Shubham Palewar UHID :UHHO25D30009 Visit ID: IH25F24007 Age/Gender: 25 Year / Male Consultant: Dr.B K Murali, MS (Orth.) Tariff: MJPJAY 1	चिपकाए	यु एच आई डी नंबर / आय पी नंबर नाम : shubham palewar उम्र : 25 years लिंग : Male

की जानेवाली प्रक्रिया ORIF + plating right femur shaft

मै पुष्टि करता हुं की मैने मरीज को प्रस्तावित एनेस्थेटिस्ट (जनरल/राजनल/सेडेशन) के प्रकार के बारें में स्पष्ट कर दिया है तो की मेरे मत से मरीज तथ/या मरीजों के अभिभावकों में उक की समझ के अनुरुप है।

हस्ताक्षर..... तारीख ....30/6/25.....

अनेस्थेटिक / कंसलटेंट का नाम : .....Dr. pranali Gurukar.....

मरीज /माता-पिता / अभिभावक :

कृपया इस फार्म तथा दुसरी तरफ दिए गये नोटिस को ध्यानपुर्वक पडे, अगर कोई स्पष्टीकरण आपको समझ न आए या आप और अधिक जानकारी चाहते हो तो डॉक्टर से पुछताछ करें।

कृपया जांच करने की फॉर्म में दी गई सभी जानकारीयां सही है। अगर ऐसा है और आपने स्पष्टीकरण को समझ लिया है तभी फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।

* जनरल एनेस्थसिया लेनेवाले मरीजो की श्वास नली में एक ट्यब (एंडोट्रेकियल इंटयुबेशन) डाली जाएगी इस ट्युब में डालने से गले मे खराश हो सकती है या आवाज भारी हो सकती है। इसके अलावा दांत या मसूडे भी ढीले हो सकते है। यदि इन्हे श्वास देने के लिये वेंटीलेटर पर रखा जा सकता। बहुत ही कम, मगर संभावना आवश रहती है।

* यह शल्यचिकित्सा आपके आपके सर्जन और संबंधित एनेस्थेटिस्ट के निर्णय के अनुसार जनरल एनेस्थीया/ स्पाइनल /एपीडयुरल लोकल एनेस्थसिया के अंतर्गत किया जा सकता है।

* साथ ही किसी तरह की एलर्जिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। यदि आपको कोई एलर्जी हो तो सुचित करे,यदि आपका पिछली शल्यचिकित्सा या एनेस्थसिया के दौरान कोई समस्या हुई हो तो अपने डॉक्टर को अवश्य बताये,

मरिज / अभिभावक का नाम (जो आवश्यक न हो उसे काट दे)

जानता हुं * कि जो प्रस्तावित है उसके बारे में इस फॉर्म में अंकित नाम के डॉक्टर ने मुझे समझा दिया है।

जानता हुं * कि प्रक्रिया उस डॉक्टर द्वारा नाकि जो मेरा उपचार कर रहे है।

* कि इस फॉर्म में वर्णित जांच-परीक्षा या उपचार के अतिरिक्त कोई अन्य प्रक्रिया तभी की जाएंगी, अगर वो आवश्यक हो तथा मेरे हित मे हो एवं चिकित्सा कारणो से उपयुक्त ठहराई जा सकती है।

सहमत हुं * कि मुझे जिस प्रकार के एनेस्थेटिक के बारें में बताया गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

१) नाम : सविता पालेवार मरीज से संबंध : माँ हस्ताक्षर : सविता पालेवार २) नाम : मरीज से संबंध : हस्ताक्षर :	मरिज के हस्ताक्षर : Subham Palewar या/और : मनोनीत हस्ताक्षरी : (विविध अभिभावक या मरीज के द्वारा प्रधिकृत) नाम : मरीज से संबध : तारीख व समय :

पुनश्च : आप सुचित सहमति पर हस्ताक्षर करने से पहले उपयुक्त कारवाही सुरू करने से पहले उस मुद्दे पर डॉक्टर से बिना किसी संकोच चर्चा कर सकते है।

Scanned with OKEN Scanner

Dr. Murali's
HOPEHOSPITAL
Assured | Committed | Proficient

Anaesthesia Monitoring Form

Name Shubham Palewar
Age 25 yrs Sex Male IP No
AMC
Allergies

Shubham Palewar
ID :UHHO25D30009
Bill ID: IH25D30017
Age/Gender: 25 Year / Male
Consultant: Dr.Dr. Afzal Sheikh (MD Medicine)
Tariff: MJPJAY 1

Diagnosis (R) Shaft femur #.
Proposed operation
(R) femur plating + SAB

Height.....
BMI.....

Past Medical History: BP/c/o Humerus + GA

Anaesthetic History
Exercise Tolerance: Not significant

HEMATOLOGY
Hb/Hct 12.3
TCL 6500
DC 56/36/05/03
Platelets 2.72 lac
BT/CT
PT/INR 1.06
APTTK

CVS S1 S2 (N)
ECG NSR, WNL
Echo
TEE
Holter

R/S B/L AEC
PFT
CXR WNL

Smokar Y/N
Alcohol Y/N

Diabetis
NIL NIDDM IDDM
F/PP/RBS
Subject to

HBSAg
HIV Non reactive
HCV
Blood Group

Nervous System Conscious, oriented
Carotids
CT Scan

Renal
Blood Urea 20.9
Creatinine 0.84

GI SYSTEM
Jaundice Y/N APD Y/N
S. Bill 0.78 D = 0.21 I = 0.57
ALK Phos 91.7
Jrinalysis
Albumin 3.98 Globulin 3.04
NA/K/Ca/Mg 138/3.88/1.19
GI Bleed
Other
SGOT/PT 13.1/17.8

AIRWAY ASSESSMENT
Mouth Opening Adequate (MPG-II)
Teeth No LT, MT
Neck Movements (N)
Spine (N)

Pulse 86/M
BP 180/86 mmHg
Allen's test
Past History Not significant

Types Of Anaesthesia:
Monitored Anaesthesia care
Sedation Anaesthesi
General Anaesthesia
Regional Anaesthesi

ASA Status 1 (2) 3 4 5 E
Risk Explained (Y)/N

Current Medication
—

Preopretive instructions
Arrange Blood product
NPO from - 8 Hours

Assessed by Dr. Pranali
Date 30/6/25

DR. M. HOPE HOSPITAL PVT. LTD.
HOPE HOSPITAL NMC Reg.No.963

Scanned with OKEN Scanner

OPERATIVE RECORD

| EVENTS | | |

pt taken on OT Table
All Multipara Monitor
attached IV line secured

No AAP SAB given
Inj - Bupivacaine 0.5% (H)
3.2 cc + Inj Bupirgesic 60 mg
in 25 G Quincke's
Spinal Needle at L3-L4
Intervertebral space
after free flow of CSF
and negative Aspiration
for Blood
LOA - Adequate

Post operative vitals
conscious, oriented
P = 86/min
BP = 116/84 mmHg
SpO2 - 99% on RA
CVS - S1S2 (N)
RS - B/L AEE

Advices
- NBM for 4 hrs
- Watch for vitals/urine output
- IVF @ 80 ml/hr NS/RL
- Post operative CBC SOS
Blood transfusion
- Inform SOS
- strict supine position for 24 hrs.

OT TIMES

Date : 30/6/25
Anaesth Start 7:15pm Arrival OT
Incision
Operation end
Anaesth end

Operation performed (R) short femur plating under SAB

Anaesthetists Dr. Pranali Gurukar
Surgeons Dr. B.K. Murali
Nurses
Perfusionist

AIRWAY Management

Mask / ETT / LMA / Traecheostomy
Size / Type / Cuff
Laryngoscope view
Grade I / II / III / IV
Difficult, why

ANAESTHETIC TYPE

GA/Sedation/Reginal
GA
Induction
Maintainence

REGIONAL

[Spinal] Epidermal Infiltration ner
Brachial Plexus
IV Regional
Lever L3-L4 intervertebral space Needle 25G Quincke's Spinal Needle
Catheter Skin mark
Position Sitting Drug Inj - Bupivacaine 0.5% (H) 3.2cc + Inj Bupirgesic 60mg

MONITOR

✓ ECG ✓ SPO2 ETCO2 temp
✓ NIBP Art Line CVP
PA catheter AGM Paw

SPECIAL TECHNIQUES

FOB Awake incubation
✓ DLT TOE CPB
POSTURE EYES EAR PLUGS

Scanned with OKEN Scanner

Events

1-.....

2-.....

3-.....

4-.....

5-.....

6-.....

7-.....

8-.....

9-.....

10-.....

CPB	ON	Clamp	ON
	OFF		Off
Time			

Heparin.....mg .....hrs .....m

.....mg.....hrs.....mg

PROTAMINE.....mg AT.....hrs

	Prebypass	Onbypass
URINE		
Anthrop. Fluid		
Blood Product		
Balance		

CPB MANAGEMENT

Additives

Cardioplegla

Temp

Return of Activity

Durg

Pacemaker

Weaning

POST CPB

_____

_____

_____

TEE

	Per Operative	Post Operative
Aorta		
RWMA		
EF		
Valves		
Others		

TRANSFER NOTES

HR -_____

ABP -_____

PA/CVP -_____

Temp - _____

MV/rate -_____

PIP -_____

SpO2 -_____

ETCO2 -_____

Scanned with OKEN Scanner